Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Rétention urinaire : bladder scan et sondage

Adulte · enfant : avis médical

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · pas d'urines avec malaise, marbrures, PAS < 100 mmHg ou confusion brutale ; fièvre avec frissons ; sang au méat après traumatisme ; hématurie abondante ou caillots après drainage.

J'applique si

- Pas de miction depuis **6 h** malgré des boissons (protections sèches) ; envie sans pouvoir uriner.
- Douleur sus-pubienne ; agitation ou changement de comportement inexpliqués.

Je n'applique pas → avis médical

- **Homme jamais sondé** ou sondage difficile : 1er sondage = médecin.
- Sang au méat, traumatisme du bassin, sténose, sphincter artificiel.
- Fièvre (prostatite ?) ; hématurie avec caillots ; enfant.
- Résistance à l'introduction : **ne jamais forcer**, retirer.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Proposer la miction (intimité, position habituelle). Sonde à demeure bouchée : la **changer**.
2. **Bladder scan** avant tout sondage (repères ci-contre).

SUR CE PROTOCOLE

3. Chercher un **fécalome** (toucher rectal) ; repérer anticholinergiques et opioïdes.
4. **≥ 400 mL** ou globe douloureux : sondage aseptique, système clos, ballonnet à l'**eau PPI** (jamais de sérum).
5. **Vidange progressive**, sans clampage. Noter le volume ; **BU + ECBU** .
6. Rétention douloureuse : sonde à demeure ; sinon aller-retour et scan à 4 h.

SUR AVIS MÉDICAL

7. Cas exclus, silodosine, arrêt d'un anticholinergique, désondage.

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Repères

Bladder scan

≥ 400 mL → sonder

250–400 mL → refaire à 1 h

< 250 mL → oligurie ?

Calibre

Femme **Ch 14** · homme déjà sondé : calibre habituel · ballonnet ≈ 8–10 mL (volume inscrit)

J'appelle le médecin

- Tout sondage, toute oligurie sans globe : médecin informé **le jour même**.
- Rétention douloureuse non drainable et médecin injoignable : **15**.

Je surveille et je trace

- **Diurèse horaire** les premières heures ; hématurie (surtout sous anticoagulant).
- Volumes (scan, drainé), sonde (Ch, ballonnet), ECBU.
- AS/AES ne sondent jamais : ils signalent une sonde coudée ou qui ne coule plus.

À retenir : Mesurer avant de sonder. Le premier sondage d'un homme reste un acte médical ; ne jamais forcer.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Arrêté du 26/06/2026 (art. 1 I et III, art. 4 II) ; ASSURE IDF, fiche 19 (2023) ; Collège français des urologues, item 347 Rétention aiguë d'urine (2021) ; Baboudjian et al., Prog Urol 2021;31:967-77 ; HUG, algorithme bladder scan (01/2024) ; OMéDIT CVL, dotations (02/2025).

Réf. DOTR-IDE-RAU | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature